儿童伤情鉴定及心理评估报告

京城市儿童医院 · 儿童保健科／儿童心理卫生科 联合检查

文书编号	JCEH-2006-CPE-0326	检查日期	2006年3月26日
被检查人	雷哲铭	性别／年龄	男／10周岁
出生日期	1995年6月28日	送检单位	秋叶孤儿院
原收养人	雷力	返院日期	2006年3月24日

一、送检事由及检查依据

儿童于原收养关系终止后返院。送检单位发现其存在多处体表损伤，伴明显恐惧、回避及睡眠异常等表现，申请对身体伤情、心理状态及可能存在的长期不当对待进行专业检查与评估。

本次采用体格检查、儿童保护性询问、临床行为观察及照护情况了解等方式形成意见。报告依据本次所见及儿童陈述出具；涉及侵害事实的法律认定不属于本报告单独能够完成的范围。

二、体格检查及伤情分析

检查所见：被检查人营养状况欠佳。双侧上臂内侧、肩背部、腰背部及下肢散见多处瘀斑、挫伤及陈旧性损伤痕迹；部分瘀斑外观提示损伤并非同一时间形成。背部可见条状软组织损伤痕迹，上臂内侧存在不规则皮下出血，局部触诊有压痛反应。

伤情分析：体表损伤涉及多个解剖部位，具有反复受力的可疑特征；现有表现难以由单次跌倒或一般活动碰撞作出充分解释。鉴于缺少全部损伤发生时的直接记录，具体致伤工具、各处损伤形成时间及机制尚需结合其他调查材料判断。

儿童陈述，原收养人雷力曾多次对其实施殴打、恐吓、惩罚性禁闭，并曾令其在寒冷天气下长时间停留室外；另反映存在饮食、睡眠及正常教育活动受限制的经历。上述情况已建议纳入后续儿童保护调查核实。

三、儿童保护性询问及行为观察

侵害相关陈述：经保护性询问，儿童明确陈述，在原收养家庭生活期间，曾多次遭受雷力实施的违背本人意愿的性接触及性侵害。询问中出现明显回避、语言中断及恐惧反应。有关经过另按儿童保护性访谈规范记录；本报告不重复列示具体侵害细节，亦不以儿童陈述替代司法事实认定。

检查过程中，儿童对成年男性靠近、突发声响、关门动作及可能引发惩罚的情境持续保持高度警觉，可见惊跳、身体僵硬、退缩及反复确认对方意图等反应。儿童自述存在入睡困难、反复噩梦，对封闭空间、夜间独处及寒冷环境有显著恐惧。

儿童反复表示“是我不听话”“爸爸生气是因为我做错了事”，并询问检查情况是否会告知原收养人；谈及既往伤害时，倾向于淡化事件严重程度，频繁道歉，较少主动表达拒绝。在紧张互动中偶有模仿猫叫的行为，可能属于其既往寻求宽容、避免惩罚的适应性应对方式。

四、心理评估意见

依据儿童陈述、临床观察及既往照护经历，初步认为其已出现显著创伤相关心理症状，并对情绪调节、自我评价及安全依恋形成不良影响。主要表现如下：

（一）持续性警觉与回避。 对特定成人、突然声响及限制行动的情境表现出明显恐惧，伴睡眠障碍、惊跳及回避反应。

（二）显著自我归责。 持续将遭受的暴力、羞辱及所述侵害归因于自身“不够听话”，存在以顺从换取安全的认知与行为模式。

（三）依恋安全感受损。 对家庭照护同时存在强烈渴望与明显不信任，对照护者情绪变化高度敏感，伴被拒绝及再次遗弃的担忧。

（四）防御性顺从及讨好。 频繁道歉、揣测成人情绪、压抑个人意愿等表现，符合长期不安全照护环境下可能形成的应对特征，不宜简单解释为一般性行为问题。

初步评估结论：儿童存在创伤后应激障碍及其他创伤相关问题的较高风险。现阶段尚不足以仅凭一次检查作出全部精神障碍的最终诊断，建议由儿童精神卫生专科结合持续观察和标准化评估进一步判断。

五、综合医学意见与处置建议

1．多部位新旧程度不一的体表损伤提示反复遭受外力伤害的高度可能，建议由相关儿童保护机构结合既往照护记录及调查材料进一步核查。

2．儿童已明确陈述曾多次遭受原收养人雷力的性侵害。应依儿童保护程序开展专项调查，妥善保存已有陈述，避免无必要的重复询问及由此造成的二次伤害。

3．儿童已表现出严重创伤相关心理反应，建议尽快接受儿童精神卫生专科复评，制定连续性的心理治疗、睡眠与情绪管理及长期随访计划。

4．建议落实安全隔离及保护性照护措施；未经风险评估与儿童保护安排，不宜让儿童与原收养人单独接触或返回原家庭。

5．后续照护应提供稳定、可预期的生活环境，尊重儿童身体边界及表达意愿，避免强制性身体接触、惩罚性管教及其他可诱发创伤反应的做法。

特别提示：儿童遭受侵害的责任不应归咎于其服从程度、个人性格或日常行为。其当前反应应置于既往照护环境及创伤经历中审慎理解。

检查科室：儿童保健科、儿童心理卫生科 出具日期：2006年3月26日

院方接收及归档：秋叶孤儿院 归档日期：2006年4月3日

备注：本文件系院内归档医疗文书电子调阅版本，按原始登记姓名展示。